

Objectif n°22 : Douleurs thoraciques aiguës : Orientation Diagnostique

OCM :

1) *La douleur thoracique secondaire à une péricardite aiguë :*

- A) Est fugace
- B) Est de siège retrosternal ou précordial
- C) Diminue en position penchée en avant
- D) Diminue en inspiration profonde
- E) Est transfixiante
- F) Survient à l'effort
- G) Est rapidement sensible à la trinitrine
- H) Est d'allure angineuse

C B H

2) *Le frottement péricardique:*

- A) Est superficiel mésocardique
- B) Irradie vers l'aisselle
- C) Est fugace
- D) Est doux humé et aspiratif
- E) Est rapeux
- F) Persiste en apnée
- G) Semble le crissement de cuir neuf
- H) Est ausculté en cas de péricardite de grande abondance
- I) Est un souffle systolique mésocardiaque

A C E FG

3) *L'étiologie la plus fréquente des péricardites aiguës est :*

- A) Néoplasique
- B) Virale
- C) Purulente
- D) Urémique
- E) Tuberculeuse

B

4) Les signes électriques évocateurs d'une péricardite aiguë sont :

- A) Un sus-décalage de ST en inférieur
- B) Un sous décalage du segment ST
- C) Un sus-décalage de PQ
- D) Des troubles de la repolarisation diffus
- E) Un bloc de branche
- F) Un BAV
- G) Un microvoltage
- H) Un allongement de PR
- I) Une onde Q

D G

5) Concernant la péricardite aiguë bénigne :

- A) La douleur est souvent prolongée de siège précordial ou retrosternal
- B) Le frottement péricardique est fugace
- C) Son traitement est basé sur la corticothérapie
- D) Le diagnostic est éliminé en cas d'absence d'épanchement péricardique à l'échographie
- E) Evolue souvent vers la constriction

A B

6) Les deux signes électriques évocateurs d'une tamponnade sont :

- A) Un sous décalage de PQ
- B) Un bloc de branche gauche
- C) Un microvoltage diffus
- D) Une alternance électrique
- E) Une HVG diastolique

C D

7) Les signes cliniques en faveur d'une tamponnade sont :

- A) Des œdèmes des membres inférieurs
- B) Des râles crépitants à l'auscultation pulmonaire
- C) Un reflux hépato-jugulaire
- D) Un pouls paradoxal de Kussmaul
- E) Un frottement péricardique
- F) Une hépatomégalie douloureuse
- G) Une pression artérielle à 170 / 90 mmHg

C D F

8) La prise en charge d'une tamponnade comporte :

- A) Un remplissage
- B) Des dérivés nitrés à la pousse seringue électrique pour diminuer la précharge
- C) Des diurétiques pour forcer la diurèse et diminuer ainsi l'épanchement
- D) Des drogues vasoactives
- E) Un drainage péricardique dans les 24 heures

A D

9) Les signes électriques suivants peuvent être rencontrés au cours d'une péricardite aiguë :

- A) Onde T négative
- B) Un sus-décalage de ST
- C) Une onde Q de nécrose
- D) Une ACFA
- E) Une déviation axiale droite

A B D

10) La douleur thoracique d'une dissection aortique :

- A) Est transfixiante
- B) Varie avec les mouvements respiratoires
- C) Peut être associée à une douleur des membres inférieurs
- D) Irradie vers la pointe du cœur
- E) Est de durée brève
- F) Est sensible à la trinitrine
- G) Est associée à un souffle systolique au foyer aortique en cas d'extension de la dissection vers les sigmoïdes aortiques

A C

11) Le signe radiologique évocateur d'une dissection aortique est :

- A) Un élargissement des espaces intercostaux
- B) Une cardiomégalie
- C) Une scissurite
- D) Un élargissement médiastinal
- E) Un épanchement pleural

D

12) Les examens qui peuvent confirmer une dissection aortique sont :

- A) Une radiographie de thorax
- B) Un électrocardiogramme

- C) Un angioscanner aortique
- D) Une échographie cardiaque trans-oesophagienne
- E) Un scanner thoracique
- F) Une échographie cardiaque trans-thoracique
- G) Un angio-IRM aortique

C D F G

13) Les signes cliniques en faveur d'une dissection aortique sont :

- A) Un souffle systolique récent au foyer mitral
- B) Un souffle diastolique récent au foyer aortique
- C) Une anisosphymie
- D) Une anisotension
- E) Des râles crépitants
- F) Un bruit de Galop
- G) Une PA à 220 / 110 mmHg

B C D G

14) Sont des complications possibles de la dissection aortique :

- A) Une insuffisance mitrale
- B) Une endocardite infectieuse
- C) Une tamponnade
- D) Un EDC
- E) Une ischémie aigue du membre inférieur
- F) Un AVC
- G) Un IDM

C D E F G

15) Le signe échographique caractéristique de la dissection aortique est :

- A) Une HVG
- B) Une bicuspidie aortique
- C) Un gradient systolique VG – Aorte
- D) Un flap intimal
- E) Une insuffisance aortique

D

16) Au cours d'une dissection aortique, l'angioscanner aortique :

- A) Est réalisé sans injection de produit de contraste.
- B) Est indiqué en deuxième intention après l'ETO.
- C) Montre le faux chenal et les portes d'entrée et sortie.
- D) Montre l'extension de la dissection
- E) Doit couvrir au moins l'aorte thoracique.

C D

17) La prise en charge d'une dissection aortique type A comporte :

- A) Un traitement anticoagulant pour prévenir les complications ischémiques.
- B) Un traitement antiagrégant pour prévenir une dissection coronaire.
- C) Un traitement antihypertenseur par voie orale en cas de chiffres tensionnels élevés
- D) Une chirurgie dans les 24 heures.
- E) Une hospitalisation en milieu de réanimation

E

18) Parmi ces circonstances, lesquelles sont à risque de dissection aortique ?

- A) Maladie de Marfan
- B) Une cardiomyopathie dilatée
- C) Une HTA mal équilibrée
- D) Une HVG
- E) Une BPCO
- F) Un anévrisme de l'aorte ascendante

A C F

19) Concernant le pneumothorax idiopathique:

- A) Il est moins fréquent que le pneumothorax secondaire
- B) Survient chez le sujet jeune longiligne
- C) Est plus fréquent avec les sujets de sexe féminin
- D) La rupture de blebs en constitue le principal mécanisme
- E) Il est souvent mal toléré
- F) Nécessite un drainage thoracique dans tous les cas

B D

20) Concernant le pneumothorax secondaire :

- A) Il survient souvent sur un poumon pathologique
- B) Son diagnostic est facile
- C) Est secondaire à une rupture de bulle d'emphysème
- D) Il récidive moins fréquemment que le pneumothorax idiopathique
- E) Est souvent bien toléré

A C

21) Les circonstances pouvant favoriser l'apparition d'un pneumothorax sont :

- A) La plongée sous marine
- B) Le port de charge lourde
- C) Le sniff
- D) L'insuffisance cardiaque
- E) L'infarctus pulmonaire

A B C

22) La survenue d'une douleur thoracique aigue chez un toxicomane à la cocaïne doit faire évoquer en premier lieu :

- A) Un spasme coronaire
- B) Une endocardite infectieuse
- C) Une embolie pulmonaire
- D) Une dissection de l'aorte
- E) Un pneumothorax

A E

23) La douleur thoracique liée au spasme œsophagien peut simuler le tableau d'une angine de poitrine, par la(les) caractéristique(s) suivante(s) :

- A) Sa survenue à l'effort
- B) Sa survenue nocturne
- C) Son siège retrosternal
- D) Sa sensibilité à la trinitrine
- E) Sa rythmicité avec les repas

C D

24) Une douleur thoracique angineuse est suspectée devant les signes suivants :

- A) Elle est de type brûlure
- B) Elle survient à l'effort
- C) Elle est reproductible à la palpation
- D) Elle est calmée par les repas
- E) Elle est positionnelle
- F) Elle est variable avec les mouvements respiratoires

A B

25) La douleur thoracique est rythmée avec les mouvements respiratoires dans les situations suivantes :

- A) Une péricardite aiguë
- B) Un syndrome coronarien aigu
- C) Une pleurésie
- D) Une dissection de l'aorte
- E) Une embolie pulmonaire

A C

26) Une douleur thoracique survenant 1 semaine après un syndrome grippal doit faire évoquer :

- A) Une embolie pulmonaire
- B) Un syndrome coronarien aigu
- C) Un spasme œsophagien
- D) Une péricardite aiguë
- E) Une myocardite aiguë
- F) Une endocardite infectieuse

D E

27) Une douleur thoracique aiguë en post partum doit évoquer :

- A) Une embolie pulmonaire
- B) Un syndrome coronarien aigu
- C) Une dissection de l'aorte
- D) Une péri-myocardopathie du post-partum
- E) Une endocardite infectieuse

A C D

28) Une douleur thoracique aiguë associée à un tableau d'insuffisance cardiaque droite aiguë doit évoquer :

- A) Une myocardite aiguë
- B) Une embolie pulmonaire
- C) Un IDM antérieur compliqué d'EDC
- D) Une péricardite minime
- E) Un pneumothorax bilatéral compressif

BE

29) Une brûlure rétrosternale majorée par l'antéflexion est en faveur de :

- A) Syndrome coronarien aigu
- B) Dissection aortique
- C) Embolie pulmonaire
- D) Reflux gastro-oesophagien
- E) Péricardite aigue

D

30) Vous évoquez le diagnostic de dissection de l'aorte chez un patient âgé de 70 ans qui se présente aux urgences pour des douleurs thoraciques aiguës. Une ou plusieurs propositions est ou sont correctes concernant votre démarche diagnostique chez ce patient :

- A) Un dosage des D-Dimères est utile si la probabilité clinique est basse
- B) Une radiographie de thorax à la recherche d'un élargissement du médiastin est indiquée quelque soit la probabilité clinique
- C) L'existence d'une valvulopathie aortique constitue une situation favorisante
- D) Un angioscanner est indiqué d'emblée si la probabilité clinique est élevée
- E) L'échographie trans-oesophagienne est indiquée au bloc opératoire particulièrement en cas d'instabilité hémodynamique

ACE

31) *Une patiente âgée de 35 ans suivie pour un lupus érythémateux disséminé, consulte pour des douleurs thoraciques évoluant depuis 06 heures précordiales dans l'intensité augmentent à l'inspiration profonde. Vous évoquez le diagnostic de péricardite aigue. Une ou plusieurs propositions est ou sont évocatrices du diagnostic chez cette patiente*

- A) La présence d'un sus décalge de l'intervalle PQ à l'électrocardiogramme
- B) Le terrain
- C) La découverte d'un sus-décalage concave du segment ST localisé dans le territoire antérieur à l'électrocardiogramme
- D) La présence d'un frottement péricardique
- E) Les caractéristiques de la douleur

BDE

32) Concernant l'apport diagnostique du dosage des D-Dimères chez un patient présentant une douleur thoracique. Une ou plusieurs propositions est ou sont correcte (s)

- A) Il est utile pour la démarche diagnostique d'une péricardite aigue
- B) Peuvent s'élever en cas de dissection de l'aorte
- C) Un dosage de D-Dimères positif affirme le diagnostic d'embolie pulmonaire avec une forte valeur prédictive positive
- D) Est utile à la démarche diagnostique d'une embolie pulmonaire chez un patient opéré d'un carcinome gastrique
- E) En cas de négativité initiale, le dosage doit être refait après 3 heures

B

33) L'embolie pulmonaire :

- A) Est une pathologie grave qui peut se compliquer d'une mort subite
- B) Est de diagnostic certain si le dosage des D dimères est élevé
- C) Est formellement éliminée si la scintigraphie pulmonaire de perfusion est normale
- D) Est exclue si l'angioscanner thoracique est normal sauf en cas de forte probabilité clinique on doit poursuivre les explorations
- E) Nécessite un traitement par la thrombolyse dans tous les cas

A C D

34) La douleur angineuse au cours du syndrome coronarien aigu sans sus-décalage de ST se caractérise par :

- A) Son siège rétrosternal
- B) Son type constrictif
- C) Sa durée qui est variable pouvant rester des heures
- D) Sa survenue à l'effort
- E) Sa sensibilité à la prise de trinitrine

ABE

35) Concernant la probabilité pré-test guidant le choix des examens complémentaires pour le diagnostic d'EP non à haut risque aux urgences, quelles sont les propositions exactes ?

- A) Elle est établie en prenant en compte les facteurs de risque d'EP.
- B) Son évaluation peut être facilitée par des scores de probabilité clinique.
- C) Quatre niveaux de probabilité clinique peuvent être distingués.
- D) Lorsqu'elle est faible, le raisonnement diagnostique est basé sur la prescription de D-dimères.

- E) Lorsqu'elle est élevée, la négativité de l'angioscanner thoracique permet d'écarter le diagnostic.

ABD

36) La douleur thoracique dans la dissection aortique :

- A) Est d'installation brutale
- B) Est fugace, de durée brève
- C) Est typiquement constrictive
- D) Constitue le signe fonctionnel le plus fréquent
- E) Peut s'associer à des douleurs des membres inférieurs

ADE

37) Les signes cliniques suivants sont évocateurs d'une tamponnade :

- A) Un pouls paradoxal de Kussmaul
- B) Un reflux hépato-jugulaire
- C) Des œdèmes des membres inférieurs
- D) Un frottement péricardique
- E) Un assourdissement des bruits du cœur

ABE

38) Les signes échographiques suivants sont en faveur d'une tamponnade:

- A) Un swinging heart
- B) Une dilatation du ventricule droit
- C) Une dilatation du ventricule gauche
- D) Un septum inter-ventriculaire paradoxal
- E) Une compression des cavités cardiaques droites

ADE

39) Le diagnostic d'une dissection aortique peut être confirmé par :

- A) Un angio-scanner aortique
- B) Une radiographie de thorax
- C) Une échographie cardiaque trans-oesophagienne
- D) Un électrocardiogramme

E) Une échographie abdominale

AC

40) Les signes électriques suivants sont évocateurs d'une embolie pulmonaire :

- A) Un microvoltage
- B) Une alternance électrique
- C) Un bloc de branche droit
- D) Un aspect S en V1 et Q en V3
- E) Une ischémie sous épigardique de V1 à V3

CE

41) Les signes radiologiques suivants sont évocateurs d'embolie pulmonaire :

- A) Des atélectasies en bandes
- B) Une opacité basale rétractile
- C) Une hyperclarté pulmonaire unilatérale
- D) Une sur-élévation de la coupole diaphragmatique
- E) Un élargissement médiastinal

ACD

42) Parmi ces examens, lequel s'il est normal, permet d'éliminer formellement le diagnostic d'embolie pulmonaire quel que soit son niveau de probabilité ?

- A) Angioscanner thoracique
- B) Electrocardiogramme
- C) Echographie cardiaque
- D) D-Dimères
- E) Scintigraphie pulmonaire de perfusion-ventilation

E

Cas clinique n°1 :

Un patient âgé de 18 ans, consulte pour douleur thoracique précordiale évoluant depuis une semaine, associée à une fièvre et inhibée par l'inspiration profonde. L'examen physique est normal en dehors d'un souffle systolo-diastolique mésocardique.

1) Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Une embolie pulmonaire
- B) Une dissection de l'aorte
- C) Une péricardite aigue
- D) Un angor spastique
- E) Une pneumopathie

C

2) *Que cherchez-vous à l'interrogatoire en faveur de votre diagnostic?*

- A) Un traumatisme thoracique
- B) Un syndrome grippal
- C) Le tabagisme
- D) Une hypertension artérielle mal équilibrée
- E) La survenue nocturne de la douleur

B

3) *Quel examen demandez-vous pour confirmer le diagnostic ?*

- A) Une radiographie de thorax
- B) Un ECG
- C) Un angioscanner thoracique
- D) Une échographie cardiaque
- E) Un angioscanner aortique

D

4) *L'examen que vous avez demandé est revenu normal. Quelle serait votre démarche diagnostique ?*

- A) Vous éliminez le diagnostic
- B) Vous demandez des troponines
- C) Vous demandez une scintigraphie pulmonaire
- D) Vous retenez toujours le diagnostic et commencez le traitement
- E) Vous demandez une coronarographie

BD

Cas clinique n°2 :

Un patient âgé de 50 ans, hypertendu, consulte aux urgences pour une douleur thoracique transfixiante, permanente, d'installation brutale et irradiante vers le dos.

L'examen physique met en évidence une pression artérielle à 200/100 mmHg au bras droit et 120/70 mmHg au bras gauche, l'auscultation cardio-pulmonaire ainsi que l'électrocardiogramme sont normaux.

1) A ce stade de l'examen, quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Une dissection aortique
- B) Une embolie pulmonaire
- C) Un pneumothorax
- D) Une pancréatite aiguë
- E) Un syndrome coronarien aigu

A

2) Quel examen demandez-vous de première intention pour confirmer votre diagnostic ?

- A) Un angioscanner aortique
- B) Un angioscanner thoracique
- C) Une échographie cardiaque trans-thoracique
- D) Une échographie cardiaque trans-oesophagienne
- E) Une radiographie de thorax

C

3) Avant de réaliser cet examen, le patient a présenté brutalement une dyspnée aiguë.

L'auscultation pulmonaire révèle des râles crépitants diffus et l'auscultation cardiaque met en évidence un souffle cardiaque. Quel est votre diagnostic ?

- A) Une insuffisance aortique aiguë secondaire à la dissection aortique
- B) Une insuffisance mitrale aiguë par rupture du pilier mitral
- C) Une insuffisance mitrale aiguë par rupture du cordage
- D) Une communication inter-ventriculaire par perforation septale
- E) Une HTAP sévère secondaire à une embolie pulmonaire massive

A

Cas clinique n°3:

Un patient âgé de 38 ans, longiligne et suivi pour une hyper-laxité ligamentaire, consulte pour une douleur thoracique brutale transfixiante irradiant vers le dos. L'examen physique trouve un patient algique, une pression artérielle à 220/110 mmHg, un souffle diastolique cardiaque et une auscultation pulmonaire normale. La température du patient est normale.

L'ECG montre un rythme régulier sinusal à 100 bpm avec absence de troubles de la repolarisation ou de la conduction.

1) Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A) Une dissection aortique
- B) Une embolie pulmonaire
- C) Un pneumothorax
- D) Une endocardite infectieuse
- E) Un syndrome coronarien aigu

A

2) Que cherchez-vous à l'examen physique pour conforter votre diagnostic ?

- A) Une hépatomégalie
- B) Un reflux hépato-jugulaire
- C) Un pouls paradoxal de Kussmaul
- D) Une asymétrie de pouls
- E) Une asymétrie tensionnelle

D E

3) Quelle est l'étiologie la plus probable du tableau clinique présenté par le patient?

- A) Une Maladie de Marfan
- B) Une valvulopathie mitrale
- C) Une thrombophilie
- D) Le statut longiligne
- E) Une maladie de Behcet

A

4) Quel(s) examen(s) complémentaire(s) peut(vent) confirmer votre diagnostic :

- A) Angioscanner aortique
- B) Echographie cardiaque trans-oesophagienne
- C) Echographie cardiaque trans-thoracique
- D) Scintigraphie pulmonaire
- E) Coronarographie

A B C

Cas clinique n°4 :

Monsieur HA âgé de 52 ans consulte les urgences pour des douleurs thoraciques rétro sternales à type de brûlures évoluant depuis 3 heures de façon paroxystique (5-10 min). Il est, tabagique à 40 PA, Diabétique de type II depuis 10 ans. Il vous rapporte qu'il a un frère décédé par un IDM à l'âge de 45 ans. Au moment où vous l'examinez, la douleur a complètement disparu. Sa PA est à 130/80 mm Hg, son pouls est régulier à 80 BPM. Le reste de l'examen clinique est sans particularités. L'ECG est normal.

1) Quelles sont, compte tenu des antécédents du patient et de la sémiologie présentée, le ou les diagnostic (s) à évoquer en priorité devant la douleur thoracique actuelle ?

- A) Embolie pulmonaire
- B) SCA avec sus-décalage de ST
- C) SCA sans sus-décalage de ST
- D) Dissection aortique
- E) Péricardite aiguë

C

2) Quelle est (sont) le ou les examens complémentaires à visée diagnostique qui vous semble(nt) utile (s) à ce stade ?

- A) Radiographie thoracique
- B) Angioscanner thoracique
- C) Répéter ECG à H6-h12 et si récurrence des douleurs.
- D) Echographie cardiaque transthoracique
- E) Cycle de troponines US H3-H6

CD

3) Les examens demandés sont revenus normaux. Le patient n'a pas récidivé les douleurs thoraciques. Quel est votre conduite à tenir chez ce patient ?

- A) Retour à domicile avec conseil de consulter en cas de récurrence de la douleur
- B) Retour à domicile un rendez-vous de consultation réglée en cardiologie
- C) Surveillance en unité de soins intensifs cardiologiques (USIC)
- D) Transfert immédiat en salle de cardiologie interventionnelle
- E) Angioscanner des coronaires en urgence

C

QROC :

1) Citer 3 signes échographiques d'une tamponnade :

Epanchement péricardique circonférentiel de grande abondance, swinging heart, compression des cavités droites, SIV paradoxal.

2) Citer les 3 complications de la péricardite aigue :

Rechute, tamponnade, constriction.

3) Citer les 4 stades électriques d'une péricardite aigue :

Stade 1 : sus décalage de ST diffus et concave en haut + T pointue, stade 2 : ST normal + T plate, stade 3 : T négative, stade 4 : ECG normal.

4) Définir le pouls paradoxal de Kussmaul :

Baisse de la PAS $\geq$ 20 mmHg après une inspiration profonde.

5) Citer 4 étiologies à l'origine d'une thoracique avec des signes d'insuffisance cardiaque droite aigue :

IDM inférieur étendu au VD, tamponnade, pneumothorax bilatéral suffocant, EP massive bilatérale (ou à risque élevée).

6) Quelle est la traduction hémodynamique d'une tamponnade ?

Adiastolie aigue.

7) Citer 2 signes radiologiques en faveur d'une tamponnade :

CMG, aspect du cœur en carafe ou théière, rectitude des bords du cœur.

8) Citer les deux types de la dissection aortique selon la classification de Stanford :

Type A : dissection de l'aorte ascendante, Type B : dissection épargnant l'aorte ascendante.

9) Citer 4 complications possibles d'une dissection aortique type A :

Hémopéricarde, dissection coronaire, insuffisance aortique aigue, AVC par dissection carotidienne.

10) Citer les 2 urgences à éliminer devant une douleur thoracique du post partum :

Embolie pulmonaire, dissection de l'aorte.

11) Citer 2 indications opératoires d'une dissection aortique type B :

Rupture (intra-thoracique, intra-abdominale...), ischémie aigue d'un membre.

12) Citer 2 signes radiologiques d'une dissection aortique :

Elargissement médiastinal, aspect en double contour du bouton aortique.

13) Citer 2 informations nécessaires apportées par l'ETT dans le cadre de la prise en charge d'une dissection aortique type A :

Hémopéricarde, insuffisance aortique aigue.

14) Citer les 2 types de pneumothorax spontané :

Idiopathique et secondaire

15) Quelle est votre conduite à tenir devant la découverte d'un pneumothorax spontané apical droit avec un décollement de 1 cm à la radiographie de thorax?

Hospitalisation – repos au lit – oxygène – surveillance clinique et radiologique.

Cas clinique QROC:

Un patient âgé de 20 ans, sans antécédents particuliers, consulte pour douleur thoracique retrosternale évoluant depuis une semaine, associée à une fièvre et exagérée par l'inspiration profonde. L'examen révèle un souffle systolo-diastolique mésocardique.

1) Quel est le diagnostic le plus probable ?

Péricardite aiguë.

- 2) Quelle est l'étiologie la plus probable ? Que cherchez-vous à l'interrogatoire pour conforter cette étiologie ?**

Péricardite virale (idiopathique). Rechercher la notion de syndrome grippal une à 2 semaines avant.

- 3) Quel examen demandez-vous pour confirmer le diagnostic ? Que cherchez-vous à cet examen ?**

Echographie cardiaque à la recherche d'un décollement péricardique.

- 4) L'examen que vous avez demandé est revenu normal. Retenez-vous encore le diagnostic ? Argumentez votre réponse.**

Oui, la péricardite aiguë peut être sèche.